

Pola Pembayaran FPKTL dengan Menggunakan iDRG

17 Juni 2026

Pusat Pembiayaan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI



3 reformasi JKN utama dibutuhkan untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pembiayaan, serta pemerataan akses Jaminan Kesehatan

Reformasi JKN akan diatur dalam **Rancangan Peraturan Presiden Jaminan Kesehatan** (RPerpres Jamkes)

1



Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBK)

Memperbaiki alur rujukan RS sesuai dengan kemampuan pelayanan untuk **mempercepat pasien dalam memperoleh layanan**

2



Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Menstandarisasi fasilitas layanan rawat inap untuk **kesetaraan akomodasi pasien**

3



Tarif layanan *Indonesian Diagnosis Related Group* (iDRG)

Menyederhanakan tarif RS berdasarkan pengelompokan penyakit di Indonesia **menghasilkan tarif lebih spesifik, klaim lebih transparan, dan mencegah fraud**

1

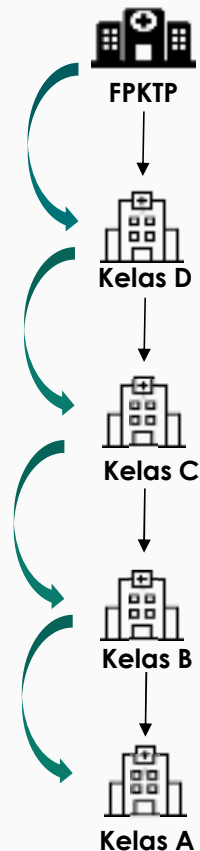
Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (Kompetensi)

Memetakan sistem rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan (kompetensi) RS sesuai dengan kebutuhan pasien

Kondisi saat ini

Rujukan berjenjang, klasifikasi berbasis bed

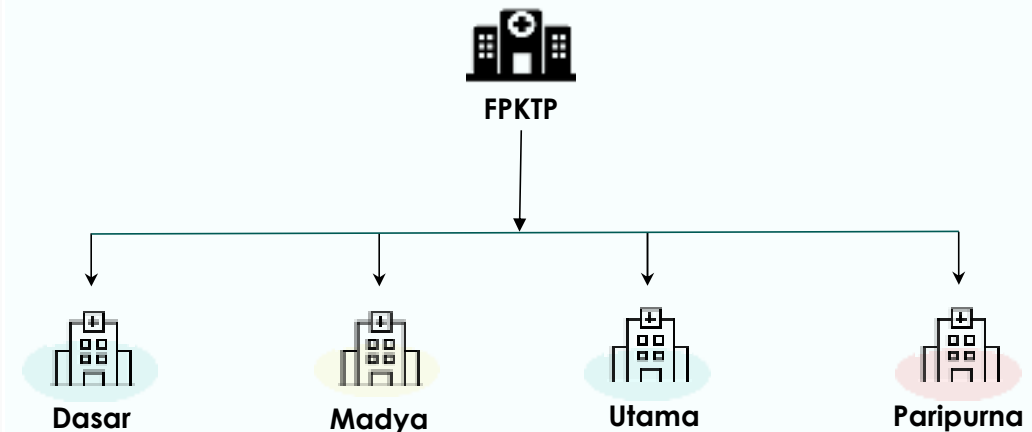
Rujukan **dimulai dari FPKTP** ke kelas RS paling bawah (Kelas D) dan **berjenjang menuju kelas RS paling tinggi (Kelas A).**



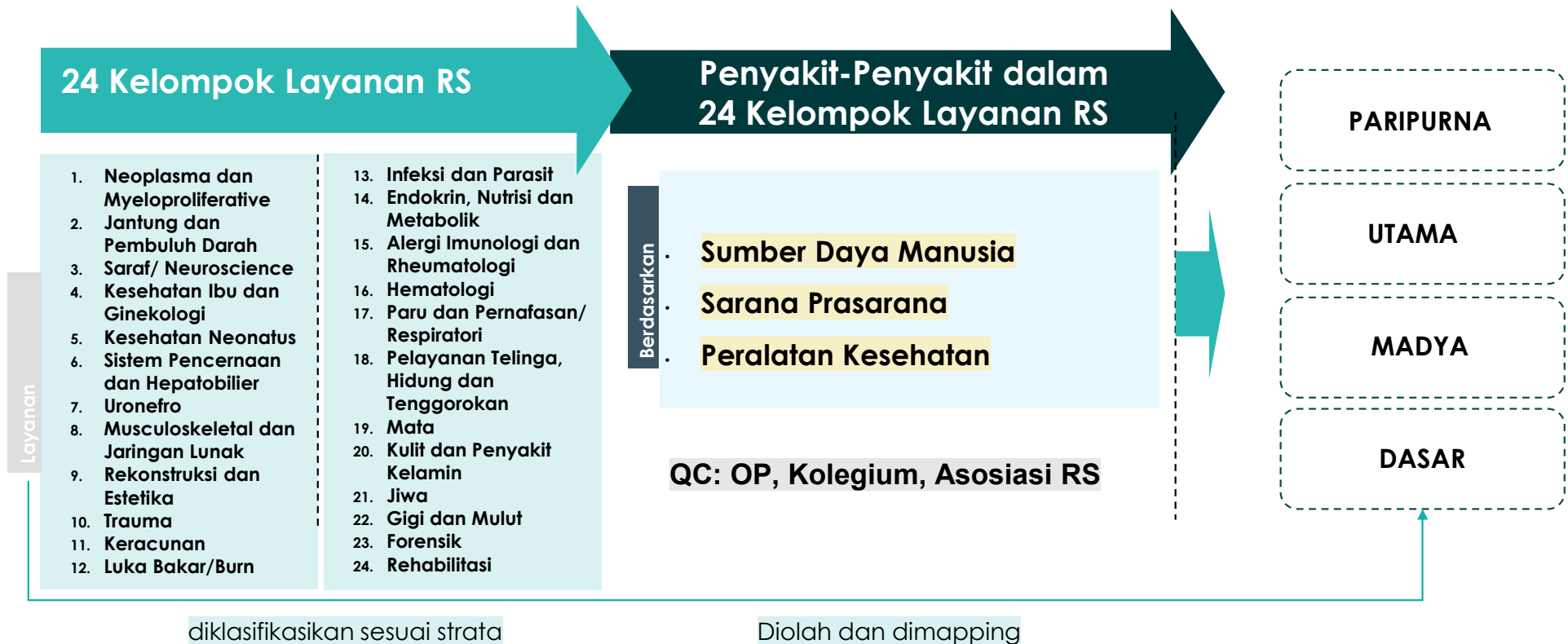
Perubahan

Rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan (kompetensi) RS

FPKTP merujuk ke RS dengan strata sesuai kebutuhan layanan pasien.



Klasifikasi Rumah Sakit berbasis Kemampuan Layanan Otomatis by System (RS Online, ASPAK, SISDMK)

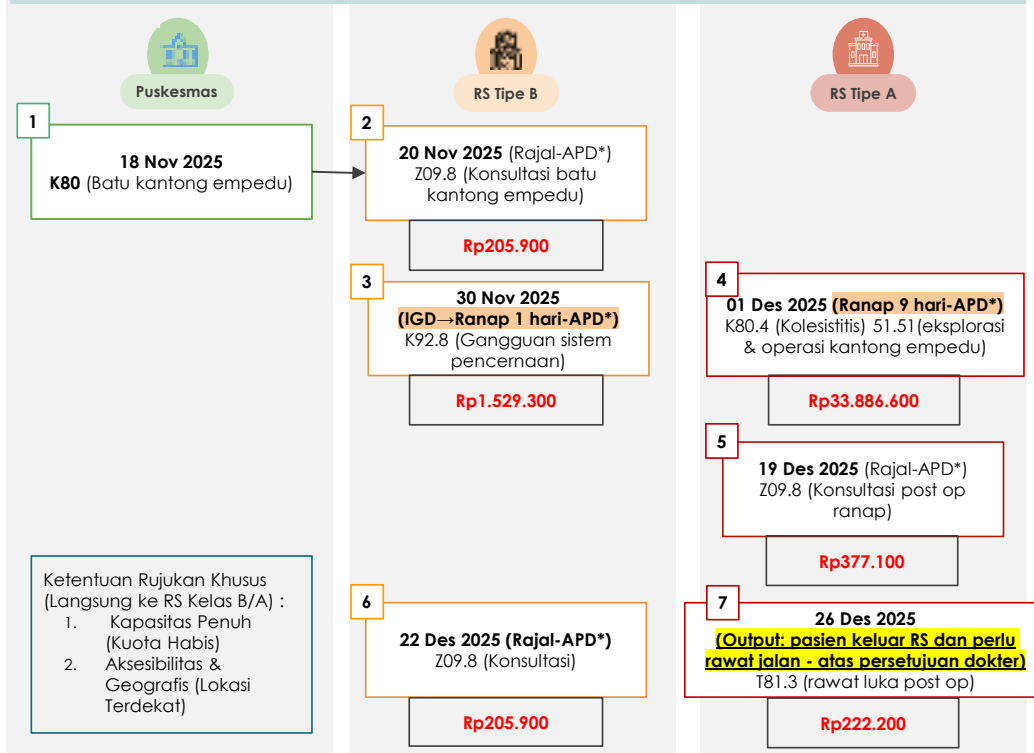


***PENTING UNTUK SELALU MENGUPDATE DATA MELALUI ASPAK, SISDMK, dan RS ONLINE**

Contoh perubahan yang akan terjadi pada *patient journey* dengan tingkat keparahan ringan

1 episode batu kandung empedu menghasilkan kunjungan berulang dan klaim berlapis; rujukan berbasis kompetensi dan iDRG menyederhanakannya

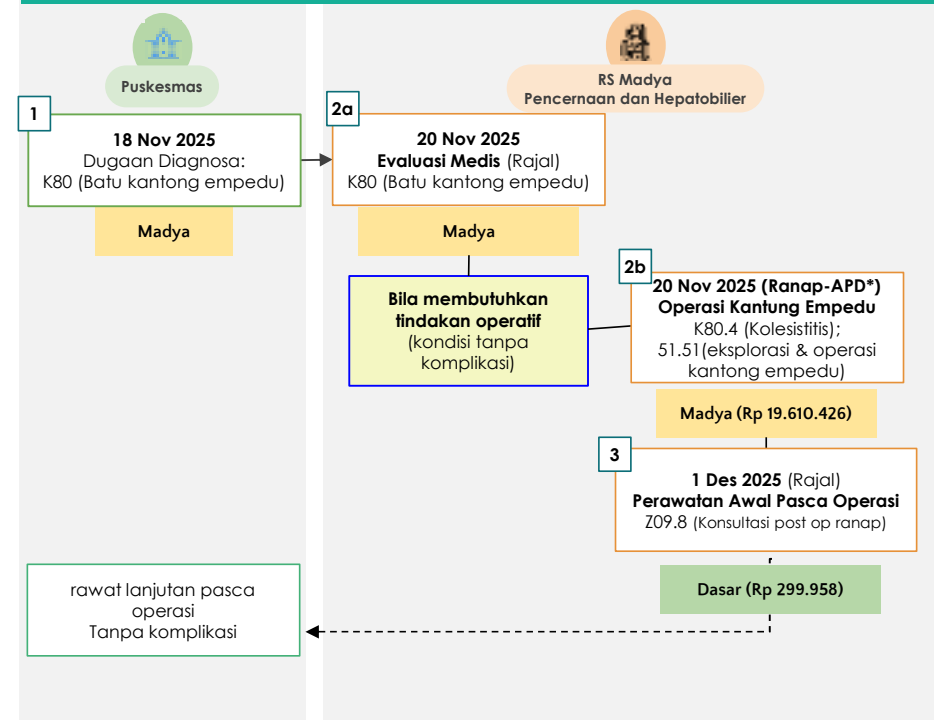
Kondisi saat ini: rujukan berjenjang kelas RS dan tarif INA-CBG



*) APD = Pulang Atas Persetujuan Dokter

Sumber Data : Data E-Klaim dan SIKDA Prov. Jawa Barat (Okt – Des 2025)

Simulasi (rencana ke depan): rujukan berbasis kompetensi dan tarif iDRG diterapkan



→ rujukan vertikal

---> rujuk balik

Total: Rp19.910.384

Durasi perawatan: ±13 hari

2

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Kementerian Kesehatan telah menyusun 12 kriteria utama fasilitas ruang perawatan KRIS

Kelengkapan tempat tidur, kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas, dan outlet oksigen merupakan kriteria yang memerlukan waktu dipenuhi RS

1



Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi

2



Ventilasi Udara Minimal 6x pergantian udara

3



Pencahayaan Ruang Min. 250 Lux dan 50 Lux untuk pencahayaan tidur

4



Kelengkapan Tempat Tidur (Nurse Call dan 2 Stop Kontak Setiap TT)

5



Nakas per Tempat Tidur

6



Temperatur Ruang 20 –26 °C

7



Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi

8



Kepadatan ruang rawat dan Kualitas tempat tidur max. 4

9



Tirai/partisi antar tempat tidur

10



Kamar mandi dalam ruangan rawat inap

11



Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas

12

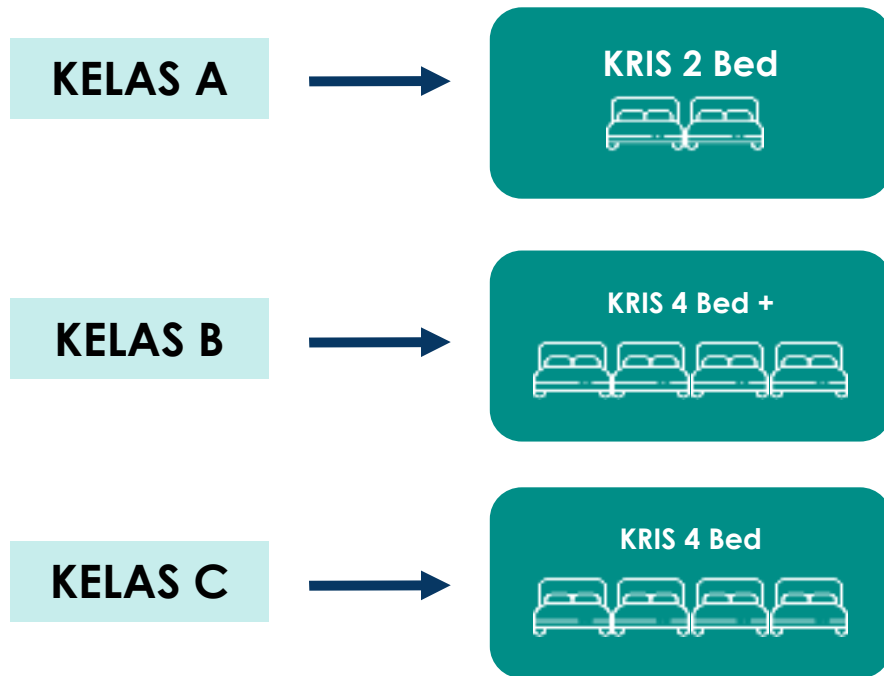


Outlet oksigen

Kriteria yang perlu waktu dipenuhi RS (capaiannya masih 84-90%)

Konsep 3 Kelas KRIS

Disepakati pada proses PAK Rperpres Jamkes

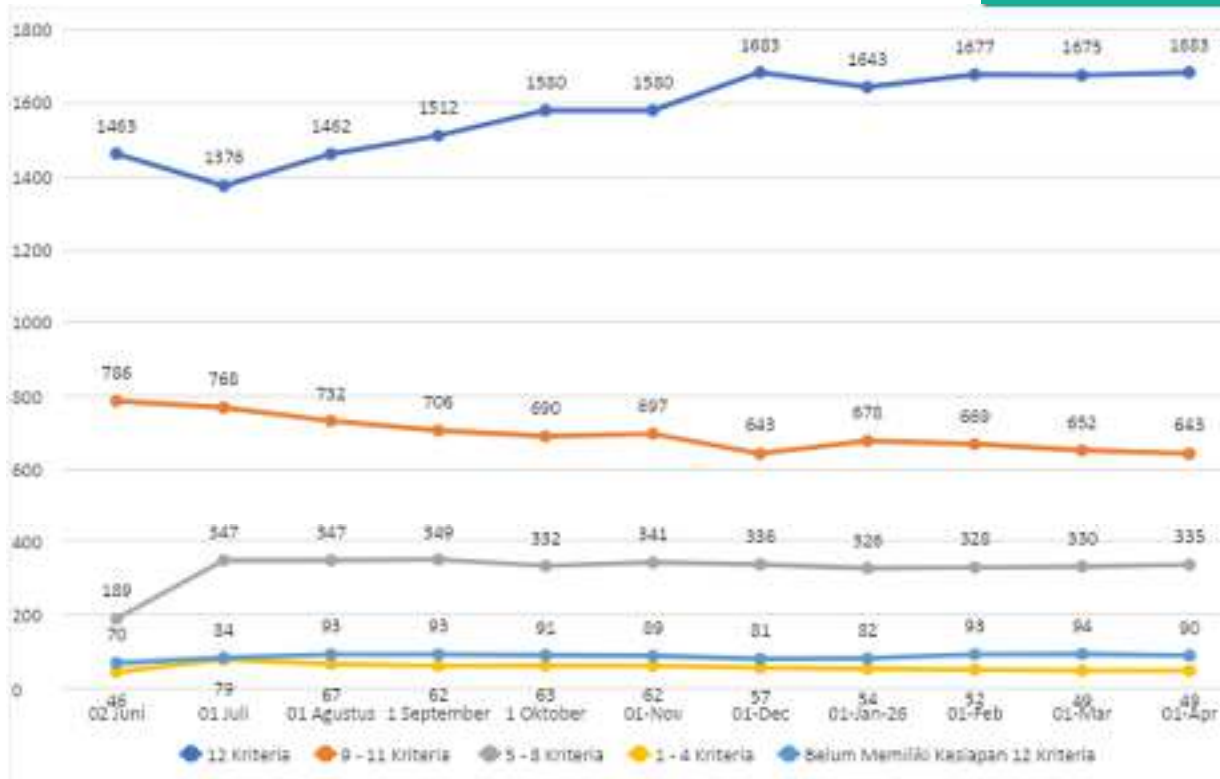


- **Maksimal 2 TT**
 - 12 kriteria utama* dengan nurse call 2 arah, pengaturan temperatur ruangan rawat inap 20°C-26°C - AC)
 - Fasilitas tambahan: **kursi penunggu pasien ditambah televisi dan dispenser/kulkas**
-
- **Maksimal 4 TT**
 - 12 kriteria utama* dengan nurse call 2 arah, pengaturan temperatur ruangan rawat inap 20°C-26°C - AC)
 - Fasilitas tambahan **kursi penunggu pasien ditambah televisi**
-
- **Maksimal 4 TT**
 - 12 kriteria utama* dengan nurse call 1 arah, pengaturan temperatur ruangan rawat inap 20°C-26°C - AC/non AC - kipas angin)
 - Fasilitas tambahan: -.

*Perbedaan kriteria fasilitas antar kelas berdasarkan 12 kriteria utama

Tren Implementasi KRIS Juni 2025 – April 2026

Jumlah RS yang memenuhi 12 kriteria meningkat 15% (220 RS) dari 1463 RS pada Juni 2025 menjadi 1683 RS pada April 2026



- Terdapat **peningkatan jumlah RS yang memenuhi 12 kriteria** dari **1463 RS menjadi 1683 RS** (220 RS atau 15%) dalam kurun waktu 11 bulan
- Terdapat **penurunan jumlah RS yang memenuhi 9 - 11 kriteria** dari **786 RS menjadi 643 RS** (143 RS atau 18%) dalam kurun waktu 11 bulan

Peningkatan layanan JKN didukung dengan rasionalisasi tarif layanan (Indonesian Diagnosis Related Group - iDRG)

Perubahan ke INA-CBG diperlukan ketika:

- 1 **Pengelompokannya masih terlampaui luas**, akibatnya tindakan-tindakan yang sangat berbeda secara klinis & sumber daya dikelompokkan dalam satu grup yang sama
- 2 **Grouper INA CBG sulit ditelusuri**, sehingga sulit memperbaiki grup yg tidak sesuai dengan pola penyakit & layanan di Indonesia
- 3 **Belum dapat membedakan tingkat keparahan** kasus sehingga menyebabkan ketidaktepatan penanganan kasus dan ketidakadilan pembayaran
- 4 **Keluhan dari Perhimpunan Profesi & Asosiasi RS** terkait pengelompokan kasus yang belum sesuai secara klinis & sumber daya
- 5 **Belum menggambarkan** kondisi penyakit masyarakat Indonesia
- 6 **Teknologi, penyakit, dan praktik medis** berkembang serta terdapat sistem/tata cara pengkodean baru

Revisi tarif diperlukan ketika:

- ✓ **Grouper berubah** sehingga klasifikasi berubah
- ✓ **Terdapat tarif layanan** yang terlalu rendah atau terlalu tinggi
- ✓ **Terdapat perubahan** teknologi atau biaya obat-obatan, BMHP, dsb

Tarif bertujuan untuk memberikan kompensasi bagi RS dengan rata-rata biaya per kasus dalam 1 (satu) grup berdasarkan penggunaan sumber daya yang standar secara nasional

Kamus

DRG (Diagnosis Related Group): sistem klasifikasi kasus berdasarkan kesamaan klinis (diagnosis dan/atau prosedur) dan kemiripan penggunaan sumber daya dalam perawatan pasien

Grouper: software klasifikasi kasus berdasarkan konsep DRG

iDRG: Indonesian Diagnosis Related Group

Apa itu iDRG?

Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG) merupakan susunan kode grup hasil pengelompokan kasus, yang memiliki tarif dan akan digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di FKRTL dalam program JKN.

Saat ini	Ke depan
Indonesian-Case Base Group (INA-CBG) Prosedur Operasi Pembedahan Caesar Ringan O - 6 - 10 - 1 ↓ CMG ↓ Case Group ↓ Case Type ↓ Severity Level • CMG (Casemix Main Group): pengelompokan berdasarkan sistem organ tubuh manusia sesuai dengan ICD-10 • Case Group: pengelompokan berdasarkan spesifikasi atau tipe kelompok kasus, seperti prosedur rawat inap, prosedur besar rawat jalan, prosedur signifikan rawat jalan, dll • Case Type: pengelompokan berdasarkan spesifik CBG (01–99) • Severity Level: tingkat keparahan kasus (ringan, sedang dan berat)	Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG) Cesarean Section w/ No CC 2 4 0 1 2 1 0 ↓ MDC ↓ PTD ↓ CL ↓ DC • MDC (Major Diagnostic Category): pengelompokan berdasarkan sistem tubuh (pernapasan, saraf, kardiovaskular, dll) atau penyakit tertentu penyebab utama perawatan • DC (Disease Cluster): pengelompokan prosedur atau diagnosis berdasarkan usia, jenis kelamin, cara pulang, dll • PTD (Patient Type Designation): pengelompokan berdasarkan tingkat layanan, yaitu rawat inap (1) atau rawat jalan (2) • CL (Complexity Level): pengelompokan berdasarkan kompleksitas dan komorbiditas (0 – 4)

Perbedaan CMG (Casemix Main Group) & MDC (Major Diagnostic Category)

Saat ini	Ke depan
23 CMG pada INA-CBG	27 MDC pada iDRG
1. G – Central nervous system 2. H – Eye and adnexa 3. U – Ear, nose, mouth & throat 4. J – Respiratory system 5. I – Cardiovascular system 6. K – Digestive system 7. B – Hepatobiliary & pancreatic system 8. M – Musculoskeletal system & connective tissue 9. L – Skin, subcutaneous tissue & breast 10. E – Endocrine system, nutrition & metabolism 11. N – Nephro-urinary system 12. V – Male reproductive system 13. W – Female reproductive system 14. O – Deliveries 15. P – Newborns & neonates 16. D – Haemopoietic & immune system 17. C – Myeloproliferative system & neoplasm 18. A – Infectious & parasitic diseases 19. F – Mental health and behavioural 20. T – Substance abuse & dependence 21. S – Injuries, poisonings & toxic effects of drugs 22. Z – Factors influencing health status & other contacts with health services 23. Q – Rawat Jalan	1. 10 – Pre MDC 2. 11 – Nervous System 3. 12 – Eye Diseases and Disorders 4. 13 – Ear, Mouth and Throat 5. 14 – Respiratory System 6. 15 – Circulatory System 7. 16 – Digestive System 8. 17 – Hepatobiliary System and Pancreas 9. 18 – Musculoskeletal System and Connective Tissue 10. 19 – Skin, Subcutaneous Tissue and Breast 11. 20 – Endocrine, Nutritional and Metabolic 12. 21 – Kidney and Urinary Tract 13. 22 – Male Reproductive System 14. 23 – Female Reproductive System 15. 24 – Pregnancy, Childbirth and Puerperium 16. 25 – Newborns and Other Neonates with Conditions Originating in the Perinatal Period 17. 26 – Blood and Blood Forming Organs and Immunological Disorders 18. 27 – Myeloproliferative Diseases and Disorders 19. 28 – Infectious and Parasitic Diseases 20. 29 – Mental Diseases and Disorders 21. 30 – Factors Influencing Health Status and Other Contacts with Health Services 22. 31 – Multiple Significant Trauma (hanya rawat inap) 23. 32 – Burns 24. 33 – Injuries, Poisonings and Toxic Effects of Drugs 25. 34 – Neoplasm 26. 35 – Rehabilitation (hanya rawat jalan) 27. 90 – Diagnostic Procedure (hanya rawat jalan)

$$\text{Tarif iDRG} = \text{Cost Weight} \times \text{National Base Rate} \times \text{Adjustment}$$

Cost Weight (CW)

Cost weight merupakan bobot biaya satu DRG tertentu terhadap biaya semua DRG.

$$\text{Cost Weight} = \frac{\text{Rata - rata biaya perawatan penyakit 1 DRG}}{\text{Rata - rata biaya perawatan semua DRG}}$$

	Minimum	Maksimum
Rawat Jalan	0,39	24,92
Rawat Inap	0,14	57,86

Casemix

Casemix menunjukkan aktivitas rumah sakit dalam bentuk jumlah dan variasi kasus, serta tingkat keparahan (*severity level*) yang dialami rumah sakit.

$$\text{Casemix} = \sum (\text{Cost Weight} \times \text{Jumlah Kasus})$$

National Base Rate (NBR)

- **NBR** merupakan tarif dasar pelayanan rumah sakit berdasarkan nilai satuan casemix secara nasional.
- **NBR** mempertimbangkan keseluruhan kasus yang ditangani di rumah sakit (dengan tingkat keparahan dan biaya yang bervariasi).

$$\text{National Base Rate} = \frac{\text{Total Biaya RS}}{\text{Casemix}}$$

Adjustment

Adjustment merupakan faktor penyesuaian yang dapat ditambahkan dalam formula perhitungan tarif DRG, seperti regionalisasi, teknologi canggih, kompleksitas kasus, dll.

Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG): Pembaruan sistem pengelompokan penyakit untuk pembayaran JKN di RS

Agar pengelompokan lebih **mencerminkan kondisi penyakit masyarakat Indonesia**

Rawat Jalan

Sistem Pengelompokan	MDC	DC	CBG/DRG
INA-CBG (PMK 3/2023)	22	289	289
iDRG	25	358	358

Rawat Inap

Sistem Pengelompokan	MDC	DC	CBG/DRG
INA-CBG (PMK 3/2023)	22	262	786
iDRG	25	560	1.005

Major Diagnostic Category (MDC) = Kelompok besar penyakit

Case Base Group (CBG) = Pengelompokan pasien berdasarkan jenis kasus untuk menentukan biaya

Diagnosis Related Group (DRG) = Pengelompokan pasien berdasarkan diagnosa dan perawatan untuk tujuan pembayaran

Perbaikan Grup Rawat Jalan: Penyakit Kronis Kecil Lain-Lain (Q-5-44-0)

- Grup Q-5-44-0 berisi pelayanan konsultasi untuk semua jenis penyakit, termasuk konsultasi kontrol yang dikoding menggunakan kode Z sebagai diagnosis primer
- Terpusatnya pelayanan konsultasi ke grup Q-5-44-0 berdampak pada sulitnya mengidentifikasi jenis penyakit di rawat jalan seperti 10 besar penyakit tertinggi
- Reklasifikasi dilakukan untuk memecah grup Q-5-44-0 menjadi 159 grup konsultasi komprehensif, *follow up*, *multispecialty*, dan *multispecialty pre-Op*

INA-CBG (Tarif PMK 3/2023 RS A Regional 1)	iDRG (Rancangan Tarif iDRG: CW*NBR _{Rajal})																
Konsultasi Q-5-44-0 (Rp377.100) Pelayanan konsultasi terpusat dalam group Q-5-44 (Penyakit Kronis Kecil Lain-Lain)	Konsultasi disebar ke seluruh MDC berdasarkan pengelompokan akut, kronis, dan neoplasma untuk konsultasi komprehensif & follow up serta non Pre Op dan Pre Op untuk konsultasi multispesialis MDC 15 Diseases and Disorders of the Circulatory System <table> <tr> <td>Acute Circulatory System Disorder</td> <td>Rp419,941</td> </tr> <tr> <td>Acute Circulatory System Disorder - Follow Up</td> <td>Rp336,876</td> </tr> <tr> <td>Chronic Circulatory System Disorder</td> <td>Rp332,261</td> </tr> <tr> <td>Chronic Circulatory System Disorder - Follow Up</td> <td>Rp295,343</td> </tr> <tr> <td>Circulatory System Neoplasms</td> <td>Rp369,179</td> </tr> <tr> <td>Circulatory System Neoplasms - Follow Up</td> <td>Rp332,261</td> </tr> <tr> <td>Circulatory System Disorder w/ Multi-specialty Consultations</td> <td>Rp544,539</td> </tr> <tr> <td>Circulatory System Disorder w/ Multi-specialty Consultations - Pre Op</td> <td>Rp456,859</td> </tr> </table> • Reklasifikasi grup Q-5-44 dengan pengelompokan kembali (<i>mapping</i>) ke semua MDC, agar mudah diidentifikasi menurut jenis penyakit: akut, kronis, dan neoplasma • Pelayanan konsultasi dibedakan menjadi 4 grup: konsultasi komprehensif, <i>follow up</i>, <i>multispecialty</i>, dan <i>multispecialty pre-Op</i>	Acute Circulatory System Disorder	Rp419,941	Acute Circulatory System Disorder - Follow Up	Rp336,876	Chronic Circulatory System Disorder	Rp332,261	Chronic Circulatory System Disorder - Follow Up	Rp295,343	Circulatory System Neoplasms	Rp369,179	Circulatory System Neoplasms - Follow Up	Rp332,261	Circulatory System Disorder w/ Multi-specialty Consultations	Rp544,539	Circulatory System Disorder w/ Multi-specialty Consultations - Pre Op	Rp456,859
Acute Circulatory System Disorder	Rp419,941																
Acute Circulatory System Disorder - Follow Up	Rp336,876																
Chronic Circulatory System Disorder	Rp332,261																
Chronic Circulatory System Disorder - Follow Up	Rp295,343																
Circulatory System Neoplasms	Rp369,179																
Circulatory System Neoplasms - Follow Up	Rp332,261																
Circulatory System Disorder w/ Multi-specialty Consultations	Rp544,539																
Circulatory System Disorder w/ Multi-specialty Consultations - Pre Op	Rp456,859																

Penyederhanaan Grup - Reklasifikasi Kasus Kemoterapi di Rawat Jalan

INA-CBG (Tarif PMK 3/2023 RS A Pemerintah Reg 1)

C-3-11-0	Kemoterapi Pada Tumor Paru & Kandung Kemih	Rp1.036.000
C-3-12-0	Kemoterapi Pada Tumor Kolon	Rp1.128.300
C-3-13-0	Kemoterapi Pada Tumor Payudara Atau Ovarium	Rp1.674.900
C-3-14-0	Kemoterapi Pada Tumor Gastrointestinal	Rp2.284.500
C-3-15-0	Kemoterapi Pada Tumor Melanoma, Ginjal, atau Prostat	Rp2.093.800
C-3-16-0	Kemoterapi Pada Tumor Otak	Rp786.800
C-3-17-0	Kemoterapi Pada Tumor Kepala Atau Leher	Rp1.598.500
C-3-18-0	Kemoterapi Pada Leukemia Akut	Rp731.400
C-3-19-0	Kemoterapi Pada Tumor Limfoma, Myeloma Atau Testis	Rp1.325.200
C-3-20-0	Kemoterapi Pada Tumor Kulit	Rp2.969.800
C-3-21-0	Kemoterapi Pada Tumor Ginekologi	Rp1.416.500
C-3-22-0	Kemoterapi Pada Tumor Metastase	Rp2.511.700
C-3-23-0	Kemoterapi Pada Tumor Lain-Lain	Rp612.800

Dari 13 grup INA-CBG yang dibedakan berdasarkan organ menjadi 2 grup iDRG yang dibedakan berdasarkan metode

iDRG (Rancangan Tarif iDRG = $CW \cdot NBR_{Rajal}$)

3445120	Chemotherapy (Injection)	Rp1.370.578
3445220	Chemotherapy (Oral)	Rp682.982

Pemisahan grup berdasarkan kelompok umur - reklasifikasi Kasus Septikemia

Dari 3 grup INA-CBG menjadi 6 grup iDRG

INA-CBG (Tarif PMK 3/2023 RS A Pemerintah Reg 1 Kelas 3)

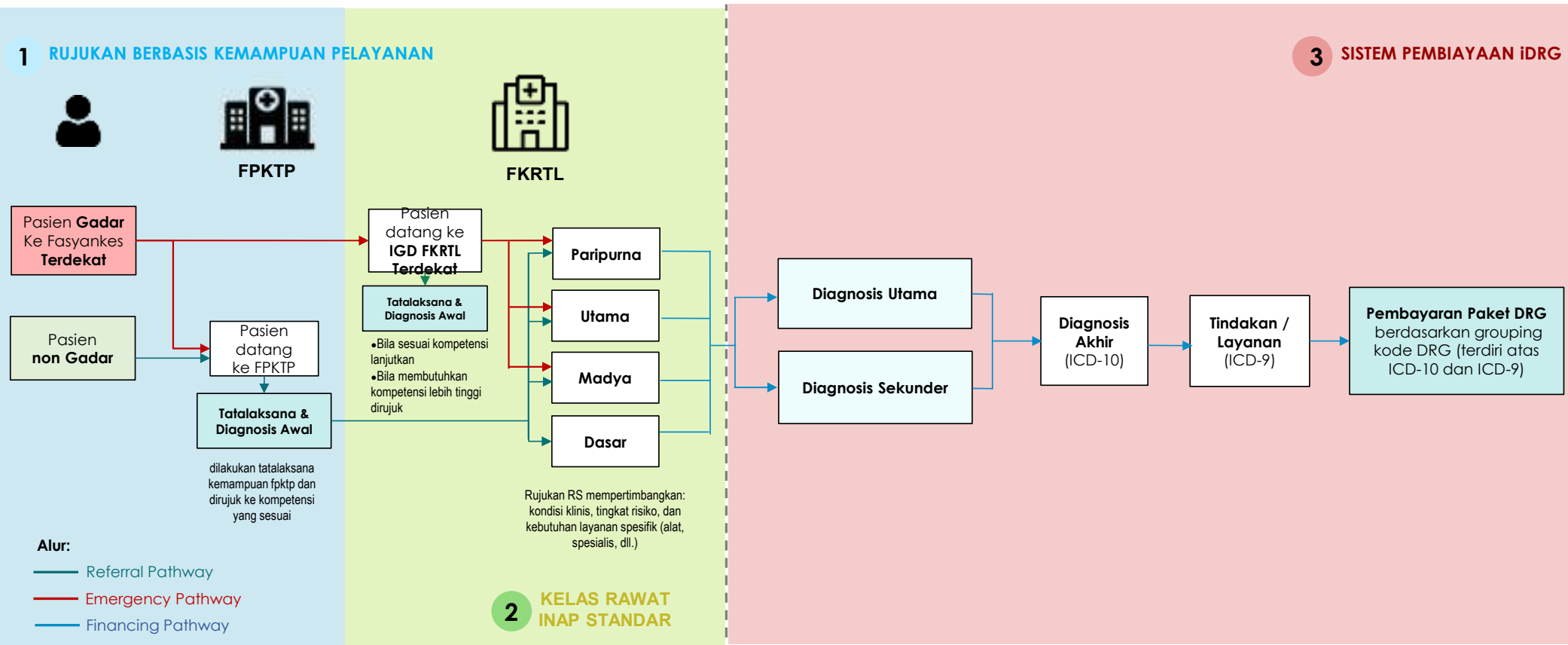
A-4-10-I	Septikemia Ringan	Rp3.702.300
A-4-10-II	Septikemia Sedang	Rp6.323.900
A-4-10-III	Septikemia Berat	Rp8.526.600

iDRG (Rancangan Tarif iDRG = $CW \times NBR_{Ranap}$)

2861110	Septicemia, Adult. w/ No CC	Rp5.545.571
2861111	Septicemia, Adult. w/ Mild CC	Rp9.483.731
2861112	Septicemia, Adult. w/ Moderate CC	Rp14.707.820
2861113	Septicemia, Adult. w/ Severe CC	Rp31.585.646
2861210	Septicemia, Child w/ No CC	Rp5.063.348
2861211	Septicemia, Child w/ Mild CC	Rp9.242.619

Septikemia adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami keracunan darah akibat bakteri dalam jumlah besar yang masuk ke dalam aliran darah.

Konsep transformasi terintegrasi **RBK**, **KRIS**, dan **iDRG** sesuai dengan *patient journey*

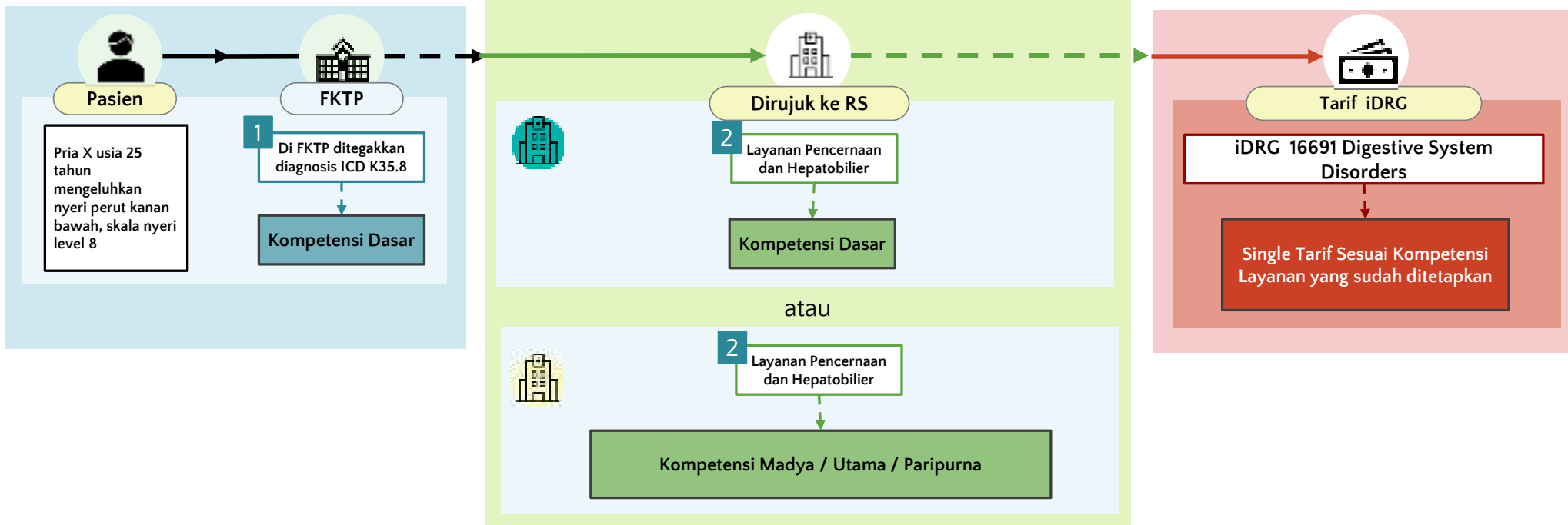


Simulasi kasus 1: Appendicitis

FKTP BERBASIS ICD-10 (DIAGNOSIS)

RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI LAYANAN PADA RS

PEMBAYARAN iDRG

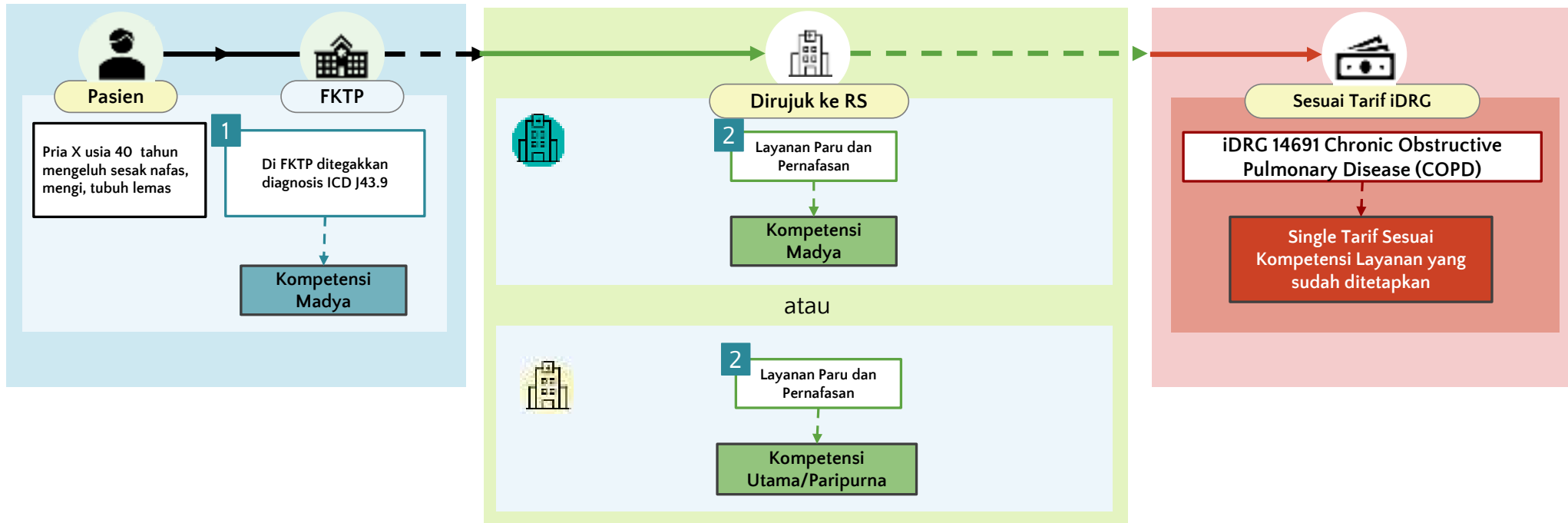


Simulasi kasus 2: Emfisema

FKTP BERBASIS ICD-10 (DIAGNOSIS)

RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI LAYANAN PADA RS

PEMBAYARAN iDRG



Note:

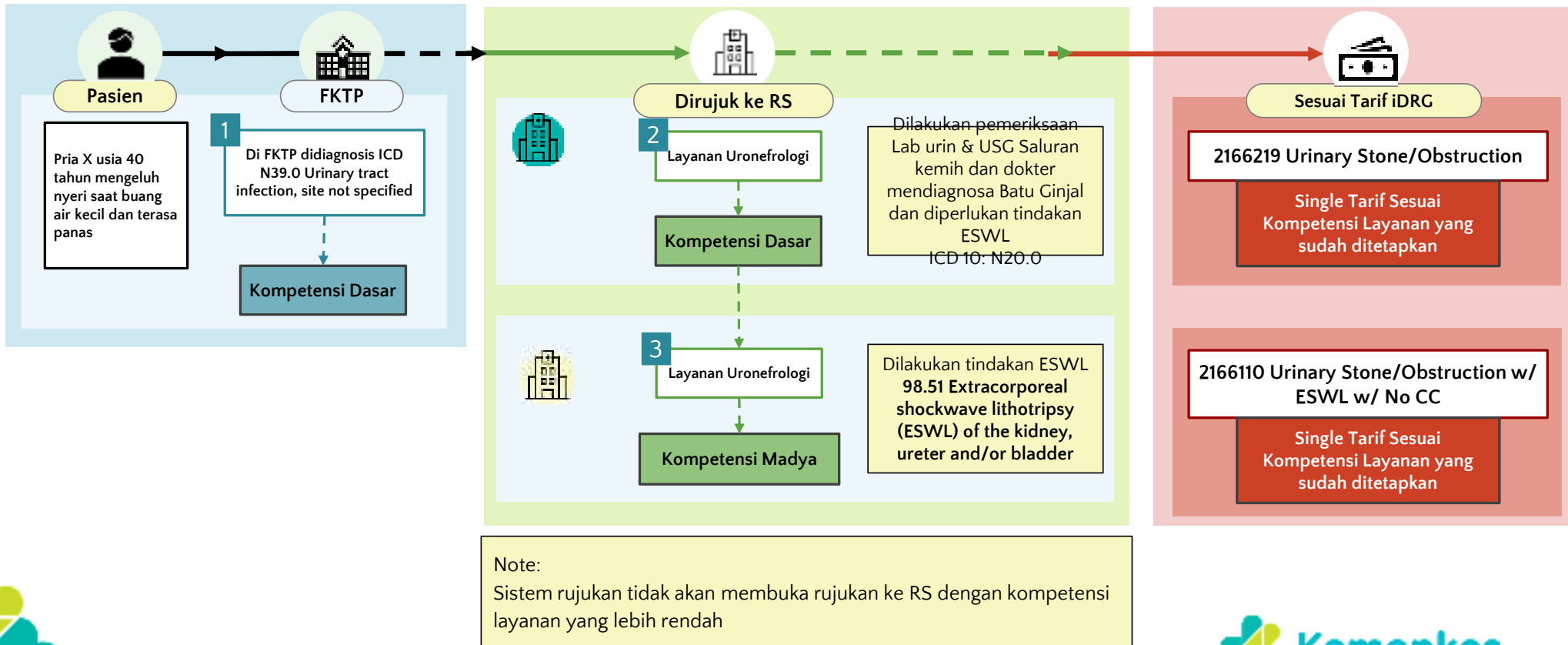
Sistem rujukan tidak akan membuka rujukan ke RS dengan kompetensi layanan yang lebih rendah

Simulasi kasus 3: Infeksi Saluran Kencing

FKTP BERBASIS ICD-10 (DIAGNOSIS)

RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI LAYANAN PADA RS

PEMBAYARAN iDRG





Strategi RS dalam Optimalisasi Klaim

- 1 Pahami Perubahan Struktur Grouper iDRG**
 - RS harus memahami logika grouping baru untuk menghindari “misclassification”
 - 2 Akurasi Clinical Severity**
 - Dokumentasikan komorbiditas, komplikasi, kondisi klinis aktual pasien secara lengkap.
 - Integrasikan dokter + koder
 - 3 Perkuat Tim Verifikasi Internal**
 - Pastikan konsistensi diagnosis–tindakan yang disertai evidence klinis lengkap dan terdokumentasikan dengan baik
 - 4 Digital Integration sebagai Critical Enabler**
 - Integrasikan SIMRS ↔ e-claim
 - Manfaatkan AI untuk verifikasi internal RS
- 